# 용종 절제술 후, 안전하게 회복하는 길

대장 용종을 떼어 낸 뒤 식사·활동·출혈 살피기·다음 검사 안내

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 늦은 출혈은 시술 당일보다 3~7일째에 많습니다

시술 뒤 2주까지는 스스로 살펴봐야 합니다 — 집에 왔다고 끝이 아닙니다

**3~7일**

**출혈이 가장 많은 시기**

시술 당일이 아니라 며칠 뒤

**2주**

**스스로 살펴볼 기간**

혈변·복통·어지럼을 매일 확인

**1~6%**

**늦은 출혈이 생기는 비율**

용종 크기·위치·복용약에 따라 다름

### 특히 조심할 분

**오른쪽 대장**에서 떼었거나 **20mm 이상 큰 용종**을 뗀 경우 늦은 출혈이 더 흔합니다.

### 매일 살펴보세요

혈변·복통·어지럼이 있는지 매일 보고, 달라지면 **바로 병원에 연락**하세요.

Tip · 퇴원할 때 받은 연락처를 2주 동안 가까이 두세요.

근거 · ESGE 2024 · USMSTF 2020 · 늦은 출혈 코호트 연구

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

# 용종 절제술 — 대장암이 되기 전에 떼어 내는 시술

대장내시경 중에 올가미·집게·열로 용종을 잘라 냅니다

### 왜 떼나요

대장 점막에 자란 용종을 **암으로 자라기 전에** 미리 떼어 냅니다.

### 회복은 빠릅니다

대부분 회복실에서 **2~4시간** 쉬고 나면 식사를 시작할 수 있을 만큼 회복됩니다.

### 상처가 아무는 데는 1~2주

뗀 자리는 작은 상처로 남아 점막이 다 아물 때까지 **1~2주**가 걸립니다. 이 기간에 출혈·천공(장에 구멍)이 늦게 생길 수 있습니다.

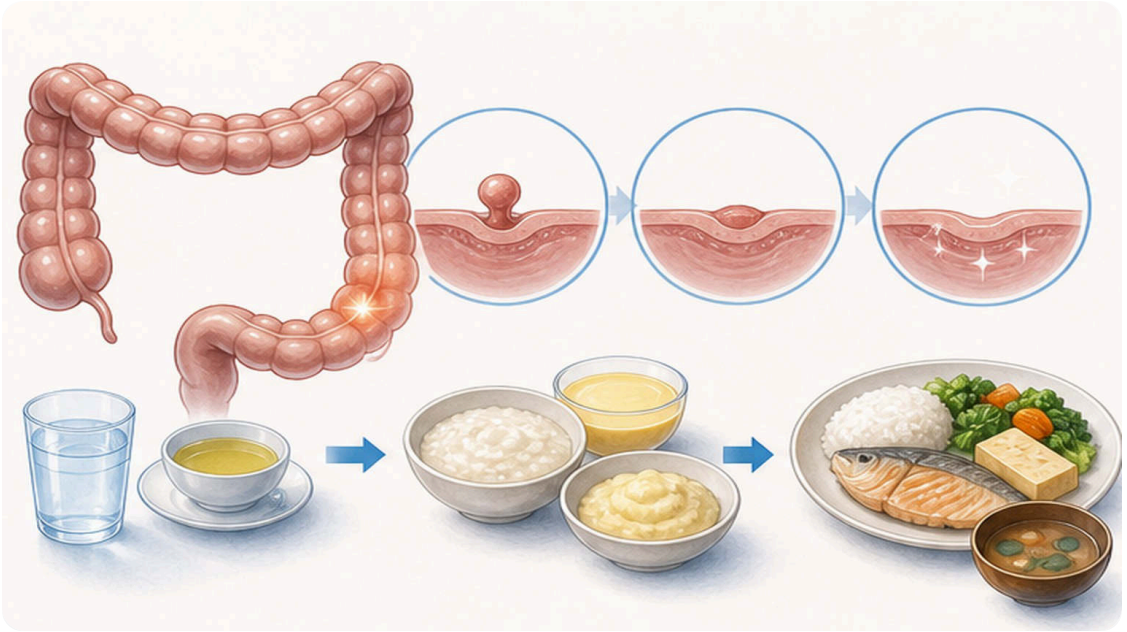


그림 · 위는 용종을 뗀 자리가 아물어 가는 모습, 아래는 물 → 죽 → 밥상으로 늘려 가는 식사입니다(설명용 그림).

Tip · 떼어 낸 용종은 모두 조직검사로 종류를 확인합니다.

근거 · ESGE 2024 · 대한소화기내시경학회 용종절제 지침

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 시술 뒤 식사는 한 단계씩 늘립니다

오래 굶는 것(3~5일 금식)보다 일찍 먹기 시작하는 것이 회복에 더 안전하다는 연구가 있습니다

**1 회복실**

2~4시간 · 금식

진정에서 깨고 의료진이 출혈·복통을 확인할 때까지 먹지 않습니다.

**2 시술 당일**

물 → 미음·죽

증상이 없으면 물부터, 이어서 미음·죽·부드러운 음식을 조금씩.

**3 1~2일 뒤**

부드러운 일반식

증상이 없으면 부드러운 일반식. 맵고 기름진 음식·씨앗·견과·질긴 고기는 줄입니다.

**4 그다음**

평소 식사

증상이 없으면 골고루 먹는 평소 식사로. 오래 가리면 오히려 해롭습니다.

**먹다가 이상하면 멈추세요** 식사 중이나 식후에 복통·혈변·어지럼이 생기면 바로 멈추고 병원에 연락하세요.

Tip · 불안하면 한 단계 전 식사로 돌아가도 됩니다(평소 식사 → 죽, 죽 → 맑은 물).

근거 · 조기 식사 재개 무작위 연구 · ESGE 2024

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 무엇을 주의하고, 무엇은 괜찮을까요

씨앗·견과·잡곡·해조류를 1~2주 모두 끊을 근거는 부족합니다 — 핵심은 '처음 며칠 자극 피하기'

### ⚠ 처음 며칠 · 피하기

매운 음식·기름진 음식, 진한 커피, 탄산음료, 과식. 술은 진정 뒤 24시간 금지, 큰 용종·소작·점막절제는 2주 피합니다.

### 처음 며칠 줄이고 · 차츰 평소대로

씨앗·견과·질긴 고기는 처음 며칠 줄입니다. 뗀 자리를 다치게 한다는 확실한 근거는 없어, 증상이 없으면 차츰 평소대로 드셔도 됩니다.

### 처음부터 권함 · 물과 부드러운 섬유질

물·보리차·미음·죽·삶은 채소·바나나. 변비로 힘을 주면 뗀 자리 출혈이 늘 수 있어 **변비 예방이 곧 출혈 예방**입니다.

### 증상이 생기면 · 바로 멈추기

먹다가 복통이 새로 생기거나 피 섞인 변·검은 변을 보면 식사를 멈추고 병원에 연락하세요.

Tip · 물을 충분히 마셔 변을 부드럽게 유지하세요.

근거 · ESGE 2024 · 광교바른내과 용종절제 후 안내문

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 활동 제한은 짧고 분명하게

작은 용종은 정해진 제한 기간이 없습니다 — 큰 용종·소작·점막절제만 2주 조심합니다



그림 · 쉬고, 가볍게 걷고, 무거운 물건은 잠시 들지 않습니다.

**1 시술 당일** 쉬기

집에서 충분히 쉽니다. 운전·기계 조작·중요한 결정은 진정제 때문에 24시간 피합니다.

**2 다음 날** 일상 활동

가볍게 걷기·집안일·사무 업무는 괜찮습니다. 무리하지 않는 선에서.

**3 작은 용종** 기간 제한 없음

증상이 없으면 평소 활동으로 돌아갑니다. 힘든 운동은 몸 상태를 보며 천천히 늘립니다.

**4 큰 용종·소작·점막절제** 2주 조심

1cm 넘는 용종이면 2주 동안 무거운 물건·격한 운동·사우나·장거리·해외여행·술을 피합니다.

Tip · 20mm 이상 큰 용종·오른쪽 대장을 뗀 분은 의료진의 개별 안내를 먼저 따르세요.

근거 · ESGE 2024 · 광교바른내과 용종절제 후 안내문

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 약은 스스로 끊지 마세요

피를 묽게 하는 약과 진통제는 의료진의 개별 안내를 따릅니다 — 무조건 1주 중단은 오히려 위험할 수 있습니다

| 약 | 어떻게 하나요 |
|---|---|
| **아스피린만 드시는 분** | 대부분 끊지 않고 그대로 드시거나 곧 다시 시작합니다. 스스로 끊으면 심장·뇌혈관 위험이 더 큽니다 |
| **와파린·먹는 항응고제·항혈소판제** | 피가 멎은 것을 확인하면 보통 **24~48시간 안에** 다시 시작을 고려합니다. 시술 다음 날 대변에 피가 보이지 않으면 최대한 빨리 다시 드세요. 장 정결 뒤 대변을 아직 보지 않았어도 다른 출혈 증상이 없으면 다음 날 다시 드세요 |
| **아플 때 먹는 진통제** | **아세트아미노펜(타이레놀)**을 먼저. 이부프로펜·나프록센 같은 소염진통제는 출혈 위험이 있어 피합니다 |
| **혈압·당뇨·갑상선 약** | 시술과 상관없는 약은 평소대로. 시술 당일 아침 약은 미리 안내받은 대로 |



그림 · 먹는 약은 의사와 상의해 끊고 다시 시작합니다.

Tip · 큰 용종·오른쪽 대장을 뗀 경우 다시 시작하는 시점을 더 신중히 정합니다.

근거 · BSG/ESGE 항혈전제 지침 2021 · ACG-CAG 2022

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 가벼운 출혈과 위험한 출혈, 이렇게 구별합니다

휴지에 묻는 적은 피는 지켜보고, 오른쪽 신호는 바로 119 또는 응급실입니다

| 살펴볼 것 | 가벼운 출혈 — 지켜보기(걱정되면 병원에 연락) | 위험한 출혈 — 바로 119 또는 응급실 |
|---|---|---|
| **피의 양** | 휴지에 살짝 묻는 정도, 변기 물은 맑음 | 변기 물이 붉어짐·검붉은 피·피덩어리 |
| **횟수** | 한두 번으로 그치고 더 나오지 않음 | 반복되거나 양이 점점 늘어남 |
| **색** | 선홍색이지만 양이 아주 적음 | 짜장면 같은 검은 변(위쪽 출혈일 수 있음) |
| **몸 상태** | 어지러움·식은땀·복통이 없음 | 어지러움·식은땀·쓰러질 것 같음·창백 |
| **맥박 · 혈압** | 평소 범위로 안정적 | 맥박이 빨라지고 혈압이 떨어짐 |
| **배** | 새로운 통증이 없음 | 새로 생긴 심한 복통·팽만·딱딱함 |

Tip · 헷갈리면 가벼운 쪽으로 판단하지 말고 병원에 먼저 연락하세요.

근거 · ESGE 2024 · 광교바른내과 용종절제 후 안내문

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 이럴 때는 바로 응급실로 가세요

시술 뒤 합병증의 분명한 위험 신호입니다 — 한 가지라도 있으면 지체 없이 119

### 변기 물이 붉어지는 혈변 · 피덩어리

뗀 자리의 늦은 출혈입니다. 특히 시술 뒤 3~7일째에 많고 바로 처치가 필요합니다.

### 새로 생긴 심한 복통 · 배가 딱딱하고 부풂

뗀 자리에 구멍(천공)이 났을 수 있어 바로 영상 검사와 처치가 필요합니다.

### 어지러움 · 식은땀 · 창백 · 쓰러짐

피를 많이 잃은 쇼크 신호일 수 있습니다. 피가 안 보여도 속에서 출혈일 수 있습니다.

### 38°C 이상 열 · 오한이 계속됨

뗀 자리 감염·복막염일 수 있습니다. 감기로 넘기지 말고 시술 사실을 알리세요.

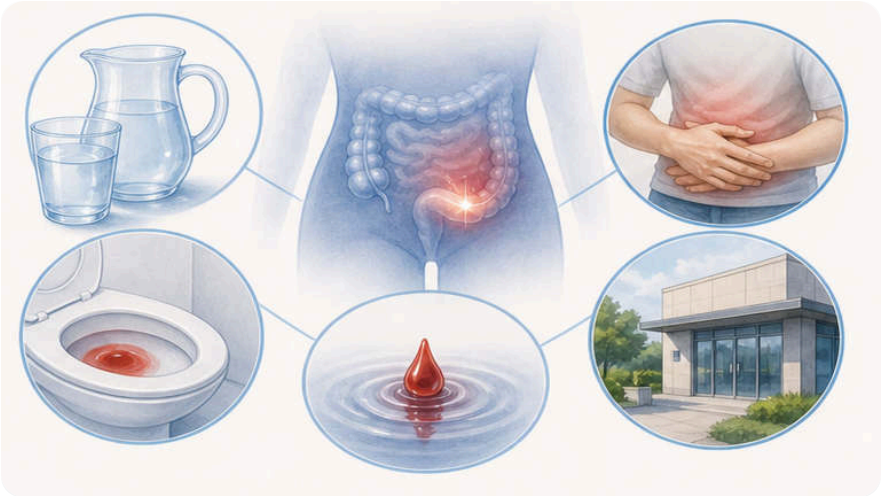


그림 · 많은 혈변·심한 복통이 있으면 기다리지 말고 병원으로 갑니다 (설명용 그림).

Tip · 응급실에서는 '며칠 전 대장 용종을 뗐다'고 꼭 알리세요.

근거 · ESGE 2024 · 용종절제 후 합병증 신호

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 조직검사 결과에 따라 다음 대장내시경 시기가 정해집니다

광교바른내과 추적 기준 — 용종 종류·크기·개수·뗀 방식에 따라 달라집니다

| 이번 결과 | 다음 검사 | 설명 |
|---|---|---|
| **용종 없음** | **5년 뒤** | 가족력이 있거나 증상이 달라지면 더 일찍 받을 수 있습니다 |
| **용종은 있으나 선종 아님** | **3~4년 뒤** | 과형성 용종처럼 암이 되지 않는 용종만 있었던 경우 |
| **선종 있음** | **2~3년 뒤** | 관상 선종처럼 흔한 양성 선종이 있었던 경우 |
| **고위험 선종 · 여러 개** | **1~2년 뒤** | 고도 이형성·융모 선종·10mm 이상 큰 병변·선종 5개 이상 |
| **2cm 이상을 나누어 뗀 경우** | **6개월 뒤** | 남은 조직이 없는지 짧은 간격으로 먼저 확인합니다 |

Tip · 나의 다음 검사 시기는 조직 결과를 보고 알려 드립니다(증상이 없다는 전제).

근거 · 원내 추적 기준(USMSTF 2020·대한소화기내시경학회 변형) · 대장용종 결과 안내문

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 2주 동안 살펴보면 안전하게 회복합니다

QR로 다시 보기 · 집에서 볼 용종절제술 후 주의사항과 대장용종 결과지 안내문을 드립니다

## 광교바른내과

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · **031-893-4560**
평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30

## 이 자료의 성격

대장 용종을 뗀 분과 가족을 위한 회복 안내자료입니다. 약 조절과 다음 검사 시기는 담당 의사와 상의해 정합니다.

## 참고한 자료

ESGE 2024 · USMSTF 2020 · BSG/ESGE 항혈전제 지침 2021 · ACG-CAG 2022 항혈전제 지침 · 대한소화기내시경학회 · 광교바른내과 용종절제 후 안내문 · 광교바른내과 대장용종 결과 안내문

SCAN TO REVISIT

**집에서 다시 보기**

QR을 스캔하면 핸드폰에서
같은 자료를 다시 볼 수 있어요